

がん化学療法（消化管がん）

●食道がん

- ・日本人の食道癌は95%以上が扁平上皮癌。
- ・**放射線療法**により、症状緩和効果が期待できる。→ **薬物!**
- ・遠隔転移のある食道癌では、全身化学療法の治療効果がある。
- ・食道癌の**通過障害**に対しては**放射線療法**を考慮する。

(ストント)

- ・Stage0：内視鏡的治療
- ・**Stage2、3で切除可能な食道がんでは術前化学療法（5-FU、シスプラチン）を行って、手術を行う。**
- ・切除可能な場合でも、手術拒否、高齢者、臓器機能障害があれば、根治目的の**放射線化学療法**（5-FU+シスプラチン+約50Gy）も考慮。
- ・**切除不能**である局所進行型や遠隔転移がある場合には、放射線療法、化学療法にて**症状緩和、延命を目指す。**

●大腸がん

- ・**RAS遺伝子野生型**であれば、**抗EGFR抗体薬**の効果が期待できる。
- ・第Ⅲ相試験において**20ヶ月を超える生存期間中央値**が得られている。

セツキシマブ、パニツプマブ

1剤：5FU+シスプラチン
2剤：ニボルマブ
3剤：ドゲキセル/シリクセル

- ・FOLFIRI（5-FU+LV+イリノテカン）、FOLFOX（5-FU+LV+オキサリプラチン）が基本。これら両レジメンを使い切り約20ヶ月超の生存期間。
- ・分子標的薬である（**ペバシズマブ**）、RAS遺伝子野生型であれば（セツキシマブ、パニツプマブ）を上記レジメンに上乗せすることで、さらに生存期間が延長
- ・薬剤費は増加しており、費用対効果の視点からも検討が進められている。

・大腸癌の肝転移後は手術適応がある。

●胃がん

- ・**HER2陽性胃がん**においては、**トラストマブ投与**を考慮する。
- ・**標準治療**（初回化学療法）は、**S-1+シスプラチン**である。
- ・胃生検検査の組織標本に、**核の大小不同、配列の乱れ**が見られる**異型腺管の浸潤**が認められた場合、**組織型は管状腺癌**である。
- ・若い女性に4型進行胃癌が発見され、腹水細胞診でクラス5と判定された。最も考えられる腫瘍の転移形式は、腹膜播種である。
- ・切除不能胃がんでは（S-1;シスプラチン）が標準治療。
- ・**臓器機能低下など**でシスプラチンが使用困難であれば、**S-1単剤**を考慮する。
- ・HER2陽性の場合（約20%）には、カペシタビン+シスプラチン+**トラストマブ**が標準治療。
- ・S-1+**オキサリプラチン**も1次治療として使用可能。

(商品名:ハーセチン)

○

- ・食道生検検査の組織標本に、異型核を有する細胞がシート状の配列を示す配列を示す腫瘍の浸潤が見られ、その中に**癌真珠**が認められた。組織型は**扁平上皮癌**であり、**分化度は腫瘍の角化量**で判定される。
- ・効果や副作用を考慮して、最も勧められるべき治療を**標準治療**と呼び、第Ⅲ相試験などのエビデンスの積み重ねにより確立する。
- ・診察、検査を行っても原発巣が特定できない固形がんのことを原発不明がんと呼び、一般的に予後不良である。
- ・Tisは、上皮内癌である。
- ・臓器によっては、わが国独自のTNM分類を用いることもある。